

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	血液採檢技術 To Draw Blood Technique				
編號	A31000-Q05-W-B40	制定者	N13 沈佳安	公布日期	98 年 03 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 4.7 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

護理人員能正確操作血液採檢技術。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

（一）技術目的

讓護理人員了解標準血液採檢流程。

（二）用物準備

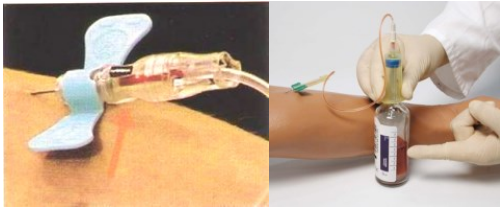
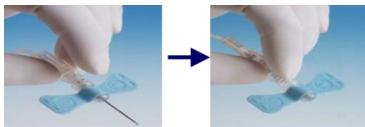
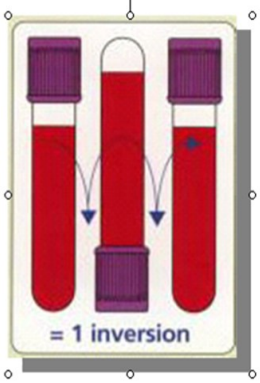
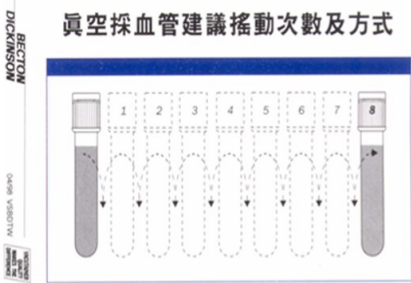
- 1.止血帶。
- 2.BD 翼型安全採血套組、多管採血轉接頭。
- 3.試管。
- 4.酒精棉片、無菌紗布 1 塊。
- 5.紙膠。
- 6.2% Chlorhexidine（血液培養時需要）。
- 7.無菌棉枝（血液培養時需要）。
- 8.手套。
- 9.護理工作車。
- 10.尖銳物收集盒。

主題名稱	血液採檢技術	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B40	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	2/8

(三) 步驟及要點說明

步驟	說明
1. 醫師開立採血醫囑及檢驗單。	
2. 護理人員核對電腦 HIS 護理系統之護理執行，核對預定執行處方名稱，核對姓名、床號、病歷號、檢驗單號及檢驗項目，依醫囑中採血項目取出正確之試管（請詳見 HIS 護理系統檢體試管圖片），並在試管上貼上病人基本資料的條碼貼紙，並於核對狀態核簽“正確”。	若為血型及 cross-matching 採檢時，要與另一位護理人員核對，並於 HIS 護理系統雙重核對後，列印條碼貼紙，貼於試管上，兩位護理人員於床邊核對病患無誤後執行抽血技術，並核對執行，檢驗單上需蓋確認章送出 (cross-matching 採檢時)。 
3. 洗手後準備採血用物，如：手套、止血帶、75% 酒精棉片、主動回縮式翼型安全採血套組 BD 翼型安全採血套組、持針器多管採血轉接頭、試管、紙膠、尖銳物收集盒等，若為血液培養則需準備 2% Chlorhexidine 及無菌棉枝，用物置於治療盤或護理工作車上攜至病人單位。	將主動回縮式翼型安全採血套組 BD 翼型安全採血套組及持針器多管採血轉接頭以無菌方式組裝完成。 
4. 辨識病人（至少二種以上方法），向病人及家屬解釋血液採檢目的並戴上手套，再次核對試管上之貼紙是否正確。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
5. 選擇採血部位後進行採血：於抽血部位上方（近心端）約 5-8 公分處綁上止血帶打一活結並請病人握拳，從遠端到近端肢體尋找適當的血管。選定血管後，如病人皮膚表面有髒汙時需先用溼紙巾/蘆薈泡沫清潔，再以 75% 酒精棉片由內往外環狀消毒 3 吋（7.62cm）採血部位（血液培養時需用 2% Chlorhexidine 擦拭後採檢），待皮膚上酒精蒸發，下針前先告知並請病人深呼吸，以主動回縮式翼型安全採血套組，針頭斜面向上穿刺靜脈抽取適量血量（採血量見“中山醫學大學附	1. 採血時，針頭斜面朝上約小於 30°，以平穩而連續之移動進入靜脈時若針頭有進入血管，會有回血的現象。若沒有回血，則輕輕移動針頭，看是否能進入靜脈，但不要勉強造成病人不舒服或傷害到血管引起凝血因子之活化。

主題名稱	血液採檢技術	制定單位	護理部	
編號	A31000-Q05-W-B40	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數 3/8

步驟	說明
設醫院檢驗科檢驗手冊”)。	 - 將已接好的持針器套入試管（培養瓶）頂端，刺穿端隔膜，收集血液至所需的量，再換第二個試管（培養瓶）。 - 採血後於靜脈內進行按壓退針處，採血部位加壓 5-10 分鐘（視病人情況而定），執行針頭回縮動作。  使用前 使用後
6. 將採集之血液注入試管後，注入加有抗凝劑的採血管後，立即 180 度輕微搖晃 6-8 次，使其充分混合，以免凝固，儘速送檢。	- 血液培養時，培養瓶口以 2% Chlorhexidine 事先消毒後再注入檢體。 - 使用安全採血套組時，血液培養瓶應先注入嗜氧瓶(Aerobic)後再注入厭氧瓶 (Anaerobic)。【※使用空針採血時，需先更換另一支新的針頭後，注入厭氧瓶 (Anaerobic)，再注入嗜氧瓶(Aerobic)】。 - 注入太快或太用力，會造成血球破裂而溶血，在不施加壓力情況下，試管本身具有真空負壓，會將血液吸入。 - 試管內若有抗凝劑，則輕搖試管使其混和，若搖晃太過劇烈會造成血球破裂。
  ※180度輕微搖晃	
7. 請病人放開拳頭，放鬆止血帶，採血部位以無菌紗布加壓 5-10 分鐘（視病人情況而定），並告訴病人不要搓揉，以免造成血管血腫。	
8. 整理用物，將持針器退出主動回縮式翼型安全採血套組，主動回縮式翼型安全採血套組針頭直接丟入尖銳物收集盒內。	
9. 洗手。	
10. 核對 HIS 護理系統於執行狀態核簽“正確”。	
11. 至 HIS 檢驗檢體傳送系統完成總包送檢。	

主題名稱	血液採檢技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B40	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	4/8

(四) 注意事項

- 1.若為生化檢查則告知病人採血前 6-8 小時禁食。
- 2.特殊時間採血檢查請確實遵守採血時間以避免檢驗結果誤差。
- 3.洗腎病人採血時請勿抽取人工血管部位。
- 4.採血依序為：血液培養瓶→藍頭 Sodine Citrate 管→黃頭 Gel 管→綠頭 Heparin 管→紫頭 EDTA 管→灰頭 NaF 管→ESR 管。
- 5.如需要冰浴之檢體，採血後應立即放置於裝有冰水之容器中再送檢。
- 6.抽血過程超過 1 分鐘之可能凝固血液不可注入含抗凝劑之試管，可注入不含抗凝劑之試管。
- 7.抽靜脈血之禁忌部位：點滴輸注或輸血之同側手臂、水腫部位、血塊部位、疤痕部位、乳房移植或手術同側手臂、動靜脈瘻管或任何導管同側手臂。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 邱淑玲(2022)·出入院病人護理·於蘇麗智等編著，實用基本護理學(九版，556-561 頁)·華杏出版。

七、附件

(略)

主題名稱	血液採檢技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B40	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	5/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.03.31	1.0	新制定	98 年 03 月 31 日 護理部技術標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.06.01	2.1	刪除：HIV 病人之檢體須貼上警示紅色標籤	100 年 06 月 01 日護理部技術標準委員會通過
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.05.13	3.1	1. 步驟 6 說明新增：以空針採血時，針頭斜面朝上約小於 30°，以平穩而連續之移動進入靜脈時若針頭有進入血管，會有回血的現象。若沒有回血，則輕輕移動針頭，看是否能進入靜脈，但不要勉強造成病人不舒服或傷害到血管引起凝血因子之活化。 2. 步驟 7 新增：採血部位以乾棉球緊壓 10 分鐘，並告訴病人不要搓揉，以免造成血管血腫。 3. 注意事項 4.修改：採血依序。	102 年 05 月 13 日護理部技術標準委員會通過
102.08.07	3.2	1.說明(二)用物準備新增：尖銳物收集盒。 2.步驟 3.治療車改護理工作車。 3.新增步驟 8.：注入加有抗凝劑的採血管後，立即上下搖晃 6-8 次，使其充分混合，以免凝固及步驟 9.新增：整理用物，針頭直接丟入尖銳物收集盒內。	102 年 08 月 07 日護理部技術標準委員會通過
102.12.04	3.3	修改步驟 8 內容及說明：注入加有抗凝劑的採血管後，立即 180 度輕微搖晃 6-8 次，使其充分混合，以免凝固及加註圖片說明。	102 年 12 月 04 日護理部技術標準委員會通過
103.06.30	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.09.16	3.4	新增主動回縮式翼型安全採血套組、持針器的說明及步驟	103 年 09 月 16 日護理部技術標準委員會通過

主題名稱	血液採檢技術	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B40	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	6/8

修正日期	版本	修正說明	備註
104.03.17	3.5	第三項第(三)目之步驟 7 說明刪除：血液培養瓶應先注入厭氧瓶後再注入嗜氧瓶；改為~血液培養瓶應先注入嗜氧瓶(Aerobic)後再注入厭氧瓶(Anaerobic)。	104 年 03 月 17 日 護理部技術標準委員會通過
104.06.18	3.6	第三項第(三)目之步驟 7 增加：使用安全採血套組時，血液培養瓶應先注入嗜氧瓶(Aerobic)後再注入厭氧瓶(Anaerobic)。(※使用空針採血時，則應先注入厭氧瓶(Anaerobic)後再注入嗜氧瓶(Aerobic)。	104 年 06 月 18 日 護理部技術標準委員會通過
104.09.29	3.7	1. 第三項第(三)目步驟 2 新增說明及圖示。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 09 月 29 日 護理部技術標準委員會通過
105.03.15	3.8	增修第三項第(三)目之 4 病人辨識說明。	105 年 03 月 15 日 護理部技術標準委員會通過
106.03.14	3.9	第三項第(三)目步驟 2 部份內容刪修，新增：請詳見 HIS 護理系統檢體試管圖片之說明。	106 年 03 月 14 日 護理部技術標準委員會通過
106.06.19	4.0	第三項第(三)目之 3 部份內容修辭。	106 年 06 月 19 日 護理部技術標準委員會通過
107.06.29	4.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.10.17	4.1	1. 第三項第二之 4 新增無菌紗布一塊。 2. 第三項第三目步驟及要點說明新增說明內容。 3. 第三項第四目新增血液培養瓶。	107 年 10 月 17 日 護理長會議通過
108.11.05	4.2	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第二目新增之 BD 翼型安全採血套組、多管採血轉接頭；2% Chlorhexidine（血液培養時需要）。 3. 第三項第三目步驟及要點說明之 3、5、6 說明內容修訂。 4. 第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 16 日 護理技術組會議通過； 108 年 10 月 09 日 護理長會議通過； 108 年 11 月 05 日 督導會議通過公布。

主題名稱	血液採檢技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B40	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	7/8

修正日期	版本	修正說明	備註
109.10.20	4.3	1. 第三項第二目刪除 2%Tincture-Iodine(血液培養時需要) 及 75%Alcohol (血液培養時需要)。 2. 第三項第三目之 3 刪除 2%Tr、75%酒精。	109 年 09 月 21 日護理技術組會議通過； 109 年 10 月 14 日護理長會議通過； 109 年 10 月 20 日督導會議通過公布。
110.09.23	4.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.05.02	4.4	1. 第三項第三目步驟 2.說明新增:檢驗單上需蓋確認章。 2. 第三項第三目步驟 5.說明:新增如病人皮膚表面有髒汙時需先用溼紙巾/蘆薈泡沫清潔後再消毒。 3. 第三項第三目步驟 6.說明新增:※使用空針採血時，需更換另一支新的針頭，再先注入厭氧瓶 (Anaerobic) 後再注入嗜氧瓶 (Aerobic)。	112 年 03 月 20 日護理技術組會議通過； 112 年 04 月 12 日護理長會議通過； 112 年 05 月 02 日督導會議通過公布
113.2.12	4.5	1. 第三項第三目步驟 5.說明 3.新增:採血部位加壓 5-10 分鐘 (視病人情況而定)。 2. 第三項第三目步驟 7.新增:採血部位加壓 5-10 分鐘 (視病人情況而定)。	113 年 03 月 18 日護理技術組會議通過； 113 年 04 月 10 日護理長會議通過； 113 年 04 月 16 日督導會議通過公布。
113.12.17	4.6	第三項第三目步驟 11.新增:至 HIS 檢驗檢體傳送系統完成總包送檢。	113 年 09 月 23 日護理技術組會議通過； 113 年 12 月 11 日護理長會議通過； 113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
115.01.06	4.7	1.第三項第三目步驟 2.刪除:檢驗單上之、檢驗單上需蓋確認章，說明:新增:檢驗單上需蓋確認章送出(cross-matching 採檢時)。 2.第六項參考資料修訂	114 年 09 月 15 日護理技術組會議通過； 114 年 12 月 10 日護理長會議通過； 115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。

主題名稱	血液採檢技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B40	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註